泌外感染和肿瘤 ★☆☆（0~2题）

肾结核

- 慢性膀胱刺激症、血尿常在膀胱刺激症后出现（2007）
- ①肾盏无或很少破坏→抗结核
  ②6~9个月无效、肾盏破坏严重、或肾无功能→抗结核＋患肾切除（术前抗结核＞2周）

肿瘤

- 肾癌（透明细胞癌多见）
  - 可有腹部肿块、同侧精索静脉曲张且平卧不消失（肾静脉或下腔静脉癌栓，2019）
  - 肾部分切除术、根治性肾切除术（2026）
- 上尿路癌（肾盂癌和输尿管癌）（移行细胞癌多见）
  - 可有条状血块、膀胱镜输尿管口喷血
  - 根治性切除肾＋全长输尿管＋输尿管开口部的膀胱壁
- 膀胱癌（移行细胞癌多见，2011）
  - 可有凝血块，无膀胱刺激症或晚期出现
  - ①非肌层浸润的膀胱移行细胞癌→经尿道膀胱肿瘤切除术 TURBT“bladder”
    ②肌层浸润的膀胱移行细胞癌（T2肌层、T3、T4）、非移行细胞癌→根治性膀胱切除＋尿流改道

多有血尿
无痛肉眼全程
（2008、2018）

- 前列腺癌（腺癌多见）
  - 好发于外周带，直肠指检触及硬结（首选）
    PSA和酸性磷酸酶“摸前列腺好酸爽”，若前列腺癌成骨性骨转移则酸性磷酸酶和碱性磷酸酶均↑（2022）
  - ①癌局限在前列腺→根治性前列腺切除术
    ②癌突破前列腺→抗雄激素药＋去势治疗（切双侧睾丸或药物抑制睾酮）

检查

- 影像学
  - 肾癌、上尿路癌最佳：增强CT和CTU（2007）
    膀胱癌、前列腺癌最佳：MRI
    怀疑前列腺癌骨转移首选：ECT
    决定肾结核治疗必不可少：静脉尿路/肾盂造影IVU/IVP
- 金标准
  - 肾结核：尿结核杆菌培养
  - 肿瘤：活检（2008）
- 尿三杯（2007、2009、2017）
  - ①全程血尿：上尿路（肾和输尿管）病变、泌外恶性肿瘤（膀胱癌多为全程血尿）
    ②初始血尿：前尿道损伤
    ③终末血尿：膀胱病变、肾结核